

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN DALAM (VAGINA TOUCHER)		
	No. Dokumen 571.7/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu tindakan yang dilakukan pemeriksaan dengan memasukkan 2 jari (telunjuk dan jari tengah tangan kanan) kedalam genetalia ,untuk mengetahui kondisi jalan lahir dan kemajuan persalinan.		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah di dalam melaksanakan melakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan 2 jari (jari telunjuk dan jari tengah) ke dalam vagina untuk menilai : a. Keadaan vulva vagina b. Keadaan serta pembukaan serviks c. Efficement d. Keadaan ketuban (sudah pecah/ belum) e. Keadaan presentasi janin f. Penurunan bagian terdahulu g. Bagian terendah janin h. Keadaan panggul dalam Kelainan-kelainan 2. Agar tindakan vaginal toucher dilaksanakan dengan efisien, Efektf, Konsiten ,dsan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.		
Prosedur	1. Siapkan alat, meliputi : a. Sarung tangan DTT/ steril b. Kapas Savlon c. Kom steril (untuk tempat sarung tangan DTT/ steril dan kapas savlon) d. Bengkok e. Larutan klorin 0,5% f. Dekatkan alat di dekat pasien 2. Lakukan persiapan klien/pasien 1. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 3. Siapkan lingkungan 1. Jaga privasi pasien dengan memasang sketsel /		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN DALAM (<i>VAGINA TOUCHER</i>)		
	No. Dokumen 571.7/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	sampiran 2. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman		
Prosedur	4. Lakukan tindakan 1. Lakukanlah 6 langkah cuci tangan 2. Pakailah APD sesuai standart (Celemek, masker, google, sepatu boot dan sarung tangan) 3. Bersihkan vulva dengan kapas savlon, basuh labia secara hati-hati, seka dari bagian depan kebelakang untuk menghindari kontaminasi feses. Savlon sekali ulas dibuang ke bengkok 4. Periksa genitalia eksterna (ada luka/ massa, kondilominata, varikosis vulva/ rectum, luka parut di perineum) 5. Nilai cairan vagina dan tentukan apakah ada bercak darah, perdarahan pervaginam atau meconium 6. Jangan lakukan pemeriksaan dalam jika ada perdarahan pervaginam 1. Jika ketuban sudah pecah, lihat warna dan bau air ketuban, jika meconium, nilai apakah kental atau encer dan periksa DJJ 2. Masukkan (hati-hati) jari tengah yang diikuti oleh jari telunjuk. Jika selaput ketuban belum pecah, jangan melakukan tindakan amniotomi (Alasan: amniotomi sebelum waktunya dapat meningkatkan risiko infeksi terhadap ibu & bayi serta gawat janin) 3. Nilai vagina 4. Nilai pembukaan dan penipisan serviks 5. Pastikan tali pusat dan / atau bagian kecil tidak teraba 5 Bereskanlah Pasien dan Alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang tidak digunakan 3. Lakukan 6 langkah cuci tangan setelah tindakan 6 Lakukan Evaluasi dan Dokumentasi 1. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 2. Dokumentasi tindakan pada rekam medik pasien		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang tindakan Kandungan & Kebidanan 3. Poli Obgyn		